

FICHA TÉCNICA PSICOMÉTRICA

INVENTARIO OBSESIVO-COMPULSIVO REVISADO (OCI-R)

Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo • Evaluación Multidimensional de Síntomas Obsesivo-Compulsivos

1. IDENTIFICACIÓN GENERAL DEL INSTRUMENTO

Nombre Oficial (Español)	Inventario Obsesivo-Compulsivo Revisado (OCI-R).
Nombre Original (Inglés)	<i>Obsessive-Compulsive Inventory-Revised (OCI-R)</i>
Autores Originales	Dra. Edna B. Foa et al. (2002), Center for the Treatment and Study of Anxiety, Universidad de Pensilvania.
Adaptación Española	Fullana et al. (2005); validado también por Belloch et al. (2006).
Eje Clínico y Clasificación	Eje I: Problemas, Síntomas y Riesgo. Evaluación dimensional de gravedad y tipificación fenotípica del TOC.
Tipo de Instrumento	Autoinforme de 18 reactivos tipo Likert (0 a 4) estructurado en 6 subescalas factoriales.
Población Diana	Adultos y adolescentes (>= 14 años). Población general y clínica de salud mental.
Tiempo de Administración	3 a 5 minutos.
Régimen de Licencia	Uso libre para fines clínicos y de investigación no comercial. No sujeto a royalties de editorial comercial.

2. FUNDAMENTACIÓN CONCEPTUAL Y MODELO COGNITIVO DEL TOC

El OCI-R es una reducción psicométrica rigurosa del OCI clásico de 42 ítems, diseñada para conservar idéntica potencia diagnóstica pero suprimiendo el tiempo excesivo de cumplimentación y la duplicidad de calificar frecuencia y malestar por separado. El modelo subyacente reconoce que el Trastorno Obsesivo-Compulsivo no es un constructo unitario, sino un síndrome heterogéneo integrado por diversas dimensiones o subtipos clínicos con correlatos neurobiológicos específicos.

Desde la neuropsicología y la neuroimagen, las diferentes dimensiones del OCI-R activan circuitos cortico-estriato-tálamo-corticales (CETC) diferenciados: el subtipo de comprobación y daño involucra la corteza prefrontal dorsolateral y el cuerpo estriado (déficit de flexibilidad cognitiva y comprobación de seguridad), mientras que la dimensión de contaminación y lavado recluta fuertemente la ínsula anterior y los ganglios basales (procesamiento del asco y repugnancia visceral). El OCI-R permite captar tanto la severidad total como el perfil fenotípico individual.

3. LAS 6 DIMENSIONES CLÍNICAS Y COMPOSICIÓN DE ÍTEMS

Dimensión OCI-R	Ítems	Rango Dir.	Contenido Fenomenológico y Semiológico
1. Lavado / Limpieza	1, 7 y 13	0 a 12	Miedo al contagio o contaminación y compulsiones repetitivas de lavado de manos o aseo excesivo.
2. Comprobación	2, 8 y 14	0 a 12	Dudas recurrentes sobre posibles descuidos y necesidad compulsiva de verificar cerraduras, gas, llaves o luces.
3. Orden / Simetría	3, 9 y 15	0 a 12	Malestar intenso o tensión si las cosas no están exactamente ordenadas, alineadas o simétricas.
4. Obsesiones / Intrusión	4, 10 y 16	0 a 12	Pensamientos o imágenes intrusivas, repugnantes o inaceptables (sexuales, agresivas o blasfemas).
5. Conteo	5, 11 y 17	0 a 12	Rituales mentales de contar objetos, números o palabras sin ninguna razón práctica.
6. Acumulación	6, 12 y 18	0 a 12	Dificultad acusada para desechar o desprenderse de objetos inservibles o sin valor económico.

PROPIEDADES PSICOMÉTRICAS, BAREMOS Y CORRECCIÓN

4. VALIDEZ, CONFIABILIDAD Y RENDIMIENTO DIAGNÓSTICO EN ESPAÑA

Consistencia Interna	Excelente confiabilidad: alfa de Cronbach global de 0.86 a 0.90 en población española (Fullana et al., 2005). Alfas de subescalas entre 0.70 y 0.85.
Estabilidad Test-Retest	Alta estabilidad temporal a 4 semanas: coeficiente de correlación intraclase $r = 0.84$ en pacientes con TOC.
Sensibilidad y Especificidad	Para el punto de corte óptimo ≥ 21 : sensibilidad del 84% y especificidad del 83% para discriminar TOC frente a controles ansiosos no obsesivos.
Validez Discriminante	Diferenciación robusta frente a trastornos de ansiedad generalizada y depresión mayor; las subescalas de comprobación y lavado muestran especificidad superior.
Estructura Hexafactorial	Confirmación factorial invariante del modelo de 6 factores independientes tanto en muestras clínicas como no clínicas.

5. REGLAS DE CORRECCIÓN Y CÁLCULO DE PUNTUACIONES

Se evalúa la intensidad del malestar causado por cada pensamiento o conducta durante el **último mes**:

- **0** = Nada | **1** = Un poco | **2** = Moderadamente | **3** = Mucho | **4** = Muchísimo.
- **Puntuación Total OCI-R**: Suma aritmética de los 18 ítems (Rango global: **0 a 72 puntos**).
- **Puntuaciones de Subescalas**: Suma directa de los 3 ítems correspondientes a cada dimensión (Rango por subescala: **0 a 12 puntos**).

6. PUNTOS DE CORTE Y ESTRATIFICACIÓN CLÍNICA (FOA ET AL., 2002; FULLANA ET AL., 2005)

Nivel	Puntuación	Estado Clínico	Interpretación y Conducta Asistencial
Subclínico	0 a 14	Población general / no clínico	Pensamientos intrusivos o comprobaciones normales dentro de la cotidianidad. No requiere intervención.
Leve Duda /	15 a 20	Rasgos obsesivos subclínicos	Presencia de síntomas obsesivo-compulsivos focales que generan malestar leve. Indagar interferencia funcional.
Clínico	21 a 38	Probable TOC (Corte ≥ 21)	Punto de corte estándar internacional. Alta sospecha diagnóstica de TOC. Requiere evaluación clínica formal (Y-BOCS) e inicio de tratamiento.
Severo	39 a 72	TOC severo e incapacitante	Afectación multidimensional masiva con rituales que ocupan varias horas al día. Terapia combinada (EPR + psicofármacos).

PUNTOS DE CORTE ESPECÍFICOS POR SUBESCALA (SUBTIPO PREDOMINANTE): Puntuaciones ≥ 4 o **5 puntos** en una subescala específica (rango 0–12) indican significación clínica en esa dimensión particular, permitiendo diseñar jerarquías personalizadas de Exposición con Prevención de Respuesta (EPR).

APLICACIÓN CLÍNICA, CASO ILUSTRATIVO Y REFERENCIAS

7. ALGORITMO DE DECISIÓN CLÍNICA Y DISEÑO DE TRATAMIENTO

UTILIDAD DEL OCI-R PARA LA EXPOSICIÓN CON PREVENCIÓN DE RESPUESTA (EPR): • **Subtipo Lavado (ítems 1, 7, 13):** Exposición gradual a estímulos contaminantes (pomos, dinero) con demora y prohibición del lavado de manos. • **Subtipo Comprobación (ítems 2, 8, 14):** Salir del hogar comprobando puertas o estufas una sola vez; entrenamiento en tolerancia a la incertidumbre. • **Subtipo Obsesiones Puras (ítems 4, 10, 16):** Exposición en imaginación a pensamientos tabú/intrusivos sin realizar neutralizaciones mentales ni oraciones. • **Monitorización de Respuesta:** Una disminución de ≥ 7 puntos en el OCI-R total indica respuesta terapéutica clínicamente significativa.

8. CASO CLÍNICO ILUSTRATIVO: TOC DE COMPROBACIÓN Y DUDA

Paciente: Varón de 27 años, bancario, que consulta porque tarda más de 90 minutos en salir de su casa por las mañanas debido a la necesidad apremiante de revisar cerraduras, grifos y enchufes, llegando reiteradamente tarde a su puesto de trabajo. **Puntuación OCI-R Total: 31 puntos (Nivel Clínico — Probable TOC).** • **Desglose dimensional:** Comprobación = 11/12 (ítem 2 = 4, ítem 8 = 4, ítem 14 = 3); Orden/Simetría = 8/12 (ítem 3 = 3, ítem 9 = 3, ítem 15 = 2); Obsesiones = 6/12 (ítem 4 = 2, ítem 10 = 2, ítem 16 = 2); Lavado = 2/12; Conteo = 3/12; Acumulación = 1/12. **Conducta Asistencial:** Diagnóstico de TOC con predominio de comprobación y necesidad de simetría. Se instauro tratamiento con TCC-EPR focalizada en comprobaciones (cerrar la puerta una sola vez sin comprobar el pomo, salir del domicilio y tolerar la ansiedad asociada) combinada con Fluvoxamina 100 mg/día. A las 10 semanas, el OCI-R total desciende a 12 puntos (reducción del 61%), saliendo de su casa en menos de 10 minutos.

9. ALERTAS DE SEGURIDAD Y DIAGNÓSTICO DIFERENCIAL

ALERTA: IDEAS SOBREVALORADAS Evaluar el grado de introspección (*insight*). Si el paciente carece de conciencia de enfermedad y cree firmemente que sus catástrofes temidas son reales, evaluar comorbilidad psicótica o trastorno esquizotípico.

TRASTORNO POR ACUMULACIÓN Puntuaciones elevadas exclusivamente en la subescala de acumulación (ítems 6, 12, 18) sugieren Trastorno por Acumulación independiente (DSM-5), que requiere abordajes asistenciales y familiares específicos.

10. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS CIENTÍFICAS

1. Foa, E. B., Huppert, J. D., Leiberg, S., Langner, R., Kichic, R., Hajcak, G., & Salkovskis, P. M. (2002). The Obsessive-Compulsive Inventory: development and validation of a short version. *Psychological Assessment*, 14(4), 485–496.
2. Fullana, M. A., Tortella-Feliu, M., Caseras, X., Andión, O., Salvador, R., & Torrubia, R. (2005). Psychometric properties of the Spanish version of the Obsessive-Compulsive Inventory-Revised in non-clinical samples. *Behaviour Research and Therapy*, 43(9), 1155–1166.
3. Belloch, A., Cabedo, E., Morillo, C., Lucero, M., & Carrió, C. (2006). Diseño de un instrumento para evaluar obsesiones y compulsiones: el Inventario de Pensamientos y Conductas Obsesivas (IPCO). *Revista de Psicopatología y Psicología Clínica*, 11(1), 27–42.
4. Abramowitz, J. S., & Deacon, B. J. (2006). Psychometric properties and construct validity of the Obsessive-Compulsive Inventory—Revised: replication and extension with a clinical sample. *Journal of Anxiety Disorders*, 20(8), 1016–1035.